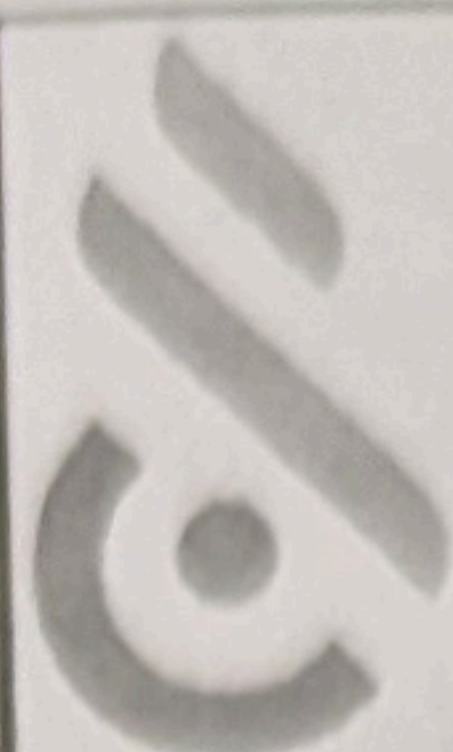


Міністерство Охорони Здоров'я України
ТОВ "ДОКТОР ФІЛІН"
Україна, м. Київ., вул. К.Малеви́ча, 86-Г; пр-
т.Л.Гузара, 3, к-5., вул. Відпочинку, 11
тел.: 237-13-43, 095-5576633, 098-5576633
Ліц. МОЗ України АВ№539367



ДОКТОР ФІЛІН

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ТОМОГРАФІЇ

Медична документація
Форма первинної облікової
документації № 028/о
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
14.02.12р. №110

ПРОТОКОЛ ОПИСУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ

Назва обстеження:

КТ органів грудної порожнини, органів черевної порожнини з заочеревинним простором та органами малого тазу до та з контрастуванням

Контрастна речовина Омніпак 350 мг йоду/мл, об'єм 100 мл. Променеве навантаження 1537 mGy*см.кв

Реакція на контрастну речовину відсутня

ПІБ пацієнта **Жерлицина Анастасія Станіславівна** ID Пацієнта 74595

Дата народження **25.04.1976** Дата обстеження **01.12.2022**

ПІБ оператора КТ який провів обстеження **Жуковська Наталія Володимирівна**

Клінічна історія:

Після попереднього КТ від 23.08.2022- ПХТ.

Протокол опису:

Над- та підключичні лімфовузли не збільшені.

Аксиллярні лімфовузли не збільшені.

Щитоподібна залоза не збільшена, одиничні дрібні гіподенсні вогнища.

Легені рівномірно пневматизовані, інфільтративних ділянок не виявлено, нечисленні дрібні вузлики до 3 мм (без динаміки). Центрилобулярні, парасептальні були, переважно у верхніх відділах.

Трахея та головні, часткові та сегментарні бронхи прохідні. Вільної рідини в плевральних порожнинах не виявлено.

Серце не збільшене, порожнини рівномірно контрастовані. В перикарді вільна рідина не візуалізується. Висхідна та низхідна аорта, цефалічні стовбури без змін. Легеневі артерії, ВПВ та НПВ не розширені, без змін.

Внутрішньогрудні лімфатичні вузли не збільшені. Стравохід не розширений, стінки його не потовщені. Діафрагма без особливостей.

Кардія, шлунок, дванадцятипала кишка, тонка та товста кишка не розширені, без достовірних уражень.

Печінка значно збільшена, ККР 220 мм, білобарно візуалізуються одиничні утворення, неоднорідної структури, з некрозом в центрі, по периферії виражена васкуляризація; в динаміці їх розміри збільшились: в Sg 8 два утворення, що зливаються між собою, загальним розміром 94x63 мм (було 79x56 мм), в Sg 2-3 - 84x56 мм (було 66x48 мм). Часткові печінкові вени, ліва ворітна вена контрастуються, права ворітна вена не візуалізується. В одному з утворень на фоні обширного некрозу виявляється невелика кількість вмісту геморагічної щільності.

Внутрішньопечінкові жовчні протоки: локальне розширення в Sg3, на іншому проміжку печінки не розширені.

В гепатодуоденальній зв'язці: ворітна вена не розширена. Холедох не розширений.

Жовчний міхур не візуалізується.

Підшлункова залоза компримована, паренхіма контрастується рівномірно. Протока залози не розширена.

Вище хвоста підшлункової залози візуалізується вузлове утворення неоднорідної щільності, з вираженою васкуляризацією, тісно прилягає до шлунку, петель голодної кишки, розміром 56x46мм (було 54x46мм, більш ймовірно не пов'язане з підшлунковою залозою, компримує її ззовні).

Селезінка не збільшена, структура однорідна. Селезінкова вена не розширена. Лімфатичні вузли воріт селезінки не збільшені.

Наднирки симетричні не збільшені.

Нирки: права зміщена вниз збільшеною печінкою, ліва розташована в типовому місці. Паренхіма обох нирок не потоншена. Кортико-медулярна диференціація не порушена. ЧМС, сечоводи не розширені. Конкременти в мисках, сечоводах відсутні. Екскреторна функція не порушена. Магістральні судини заочеревинного простору без змін.

Лімфатичні вузли заочеревинного простору: нечисленні парааортальні до 9 мм по короткій осі (без динаміки).

Сечовий міхур - стінки не потовщені, внутрішньопросвітних утворень немає.

На рівні дна матки, вище сечового міхура - вузлове гетерогенне утворення (субсерозне), з вираженою васкуляризацією, з одиничними дрібними кальцинатами, розміром 87x64 мм (було 95x63 мм);

Тіло матки не збільшене, по правій поверхні вузол без суттєвої динаміки 37x27 мм (міома).

Вище та правіше матки- округле утворення 67x52 мм (без суттєвої динаміки, було 67x57 мм, без явного накопичення контрасту-геморагічна кіста правого яєчника?).

Яєчники диференціюються, не збільшені. Невелика кількість рідини в тазу.

Лімфатичні вузли черевної порожнини, малої миски, пахові не збільшені.

В кістках без деструктивних вогнищ.

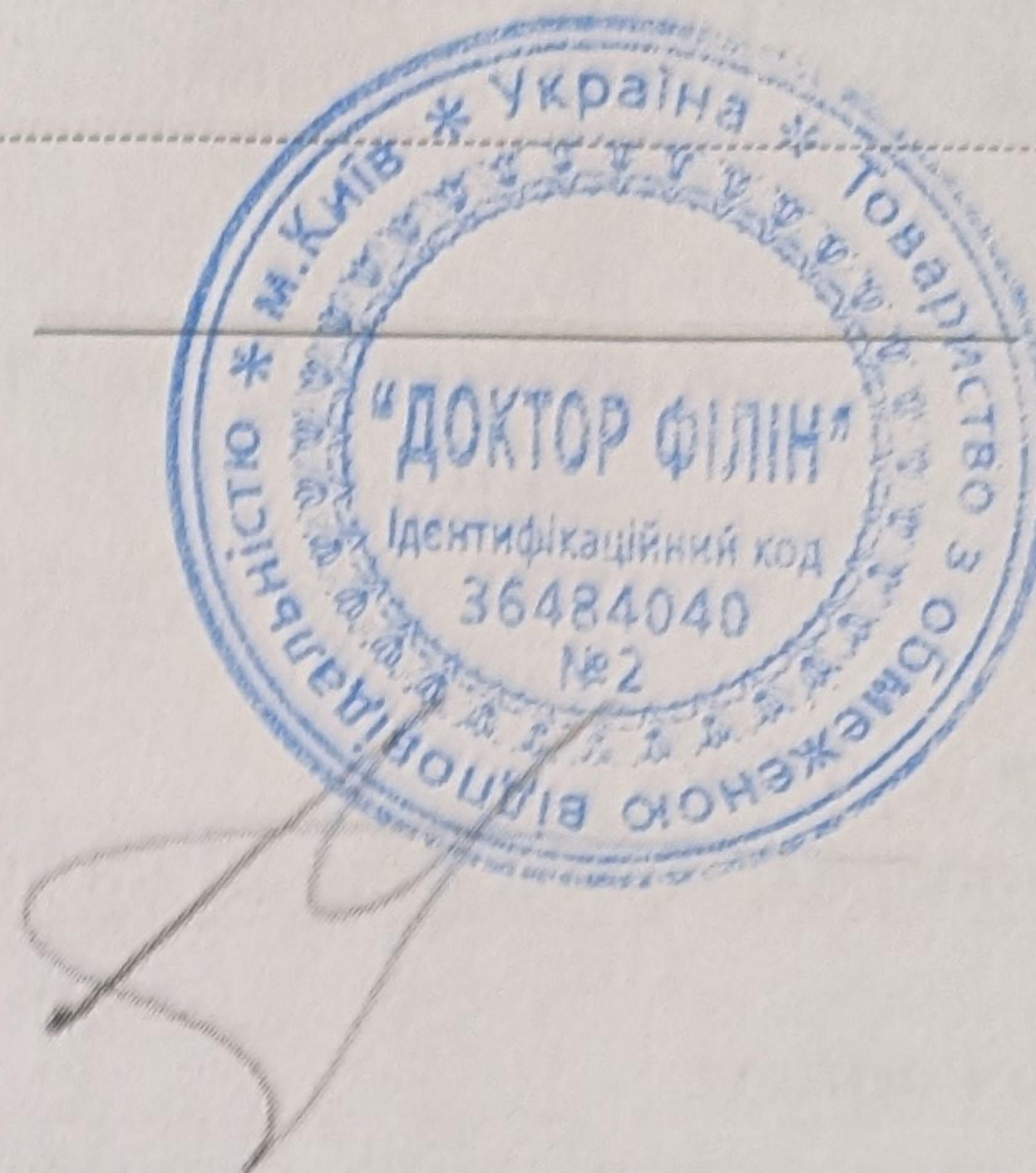
Заключення:

Са матки за даними ПГЗ, Мтс в печінку білобарно, новоутворення в черевній порожнині на рівні шлунку-хвоста підшлункової залози (імплант).
Міома матки, геморагічна кіста ? правого яєчника. Одиичні дрібні вузлики в легенях- без динаміки.
Порівняно з попереднім КТ від 23.08.2022- збільшення розмірів утворень в печінці, помірне зменшення вузла на рівні дна матки; в іншому- без суттєвої динаміки.

Рекомендації:

Контроль в динаміці, співставлення з даними МРТ малого тазу.

Дата: 01.12.2022



М.П.

Лікар-рентгенолог:

Целованська Лія Вікторівна

(підпис)

*Дане заключення не є клінічним діагнозом. Даний документ має бути інтерпретований лікуючим лікарем у відповідності з клінічною картиною.